

TEMA 2.14 • GINECOLOGÍA

Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea

PERFIL EUNACOM 2.01.1.079

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea

Causas

TABLA 2.14.1: TIPO VS CAUSAS	
TIPO	CAUSAS
Ginecológicas	Dismenorrea primaria (más frecuente de todas), endometriosis, adenomiosis, malformaciones uterinas
Digestivas	SII (más frecuente de causas no ginecológicas), enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer de colon
Otras	Cáncer de ovario, causas urinarias

Enfrentamiento General

Clave: Determinar si el dolor es **cíclico** (relacionado con el ciclo menstrual) o **no cíclico**.

TABLA 2.14.2: TIPO DE DOLOR VS SOSPECHA		
TIPO DE DOLOR	SOSPECHA	ESTUDIO
Cíclico	Causa ginecológica = dismenorrea	ETV
No cíclico	Causa digestiva u otras	Estudiar según sospecha clínica

Excepción importante: Si se sospecha **endometriosis** con ETV normal → **laparoscopia** (gold standard diagnóstico).

Dismenorrea Primaria vs. Secundaria

TABLA 2.14.3: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	PRIMARIA	SECUNDARIA
Inicio	Desde la menarquia (primera menstruación)	Aparece años después de la menarquia
Intensidad	Leve a moderada	Moderada a intensa y progresiva
Examen físico	Normal	Alterado (útero globoso, masa, etc.)
Ecografía	Normal	Puede mostrar causa
Causa	Idiopática (prostaglandinas)	Endometriosis, adenomiosis, malformaciones
Tratamiento	AINes (ácido mefenámico)	Tratar la causa + AINes para el dolor

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla rápida: - Dolor desde la primera regla + examen normal = dismenorrea **primaria** - Dolor que inicia a los 30-40 años, progresivo = dismenorrea **secundaria** → buscar causa

Clínica Diferencial de Dismenorreas Secundarias

Adenomiosis

- Dismenorrea secundaria + **hipermenorrea** - Útero aumentado, **liso y globoso** - ETV: miometrio heterogéneo

Endometriosis

- Dismenorrea secundaria **progresiva** - Sin hipermenorrea ni metrorragia (sin alteración menstrual) - Síntomas adicionales: **dispareunia profunda**, **disquecia** (dolor al defecar) - Infertilidad - ETV puede ser normal (diagnóstico por laparoscopia)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Endometriosis: El único síntoma es **dolor + infertilidad**. No tiene hipermenorrea ni leucorrea. Si hay hipermenorrea + útero globoso → adenomiosis.

Tratamiento

TABLA 2.14.4: CONDICIÓN VS TRATAMIENTO	
CONDICIÓN	TRATAMIENTO
Dismenorrea primaria	AINes (ácido mefenámico)
Dismenorrea secundaria	Tratar causa + AINes
Adenomiosis	Histerectomía (paridad cumplida) u observación + GnRH agonistas

| Endometriosis sospechada | ETV → si normal: **laparoscopia diagnóstica** |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Causas
- Enfrentamiento General
- Dismenorrea Primaria vs. Secundaria
- Clínica Diferencial de Dismenorreas Secundarias
- Adenomiosis
- Endometriosis
- Tratamiento

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ALGIAS PÉLVICAS CRÓNICAS (APC) Y DISMENORREA)**PREGUNTA 1**

Respecto a Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Algias Pélvicas Crónicas (APC) y Dismenorrea. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: ALGIAS PÉLVICAS CRÓNICAS (APC) Y DISMENORREA

Excepción importante: Si se sospecha endometriosis con ETV normal → laparoscopia (gold standard diagnóstico). :::warning
Endometriosis: El único síntoma es dolor + infertilidad. No tiene hipermenorrea ni leucorrea. Si hay hipermenorrea + útero globoso → adenomiosis. :::